ONEMA-POP-062 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Triagem de Suspeita de Infecção de Pele e Partes Moles em Membros Inferiores

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de triagem de suspeita de infecção de pele e partes moles em membros inferiores, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Termômetro, esfigmomanômetro, oxímetro, EPIs, régua para extensão do eritema. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Avaliar extensão, progressão, dor, calor, edema, febre, trauma, imunossupressão e diabetes. Confirmar identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Caracterizar início, progressão e local; diferenciar inflamação, celulite e possíveis diagnósticos alternativos.

02. Avaliar sinais sistêmicos, dor desproporcional, bolhas, crepitação, necrose e comprometimento vascular.

03. Registrar limites de eritema se apropriado e fotografar apenas com consentimento.

04. Não realizar incisão, drenagem ou iniciar antibiótico sem competência e prescrição aplicáveis.

05. Na suspeita de infecção necrosante ou sepse, acionar SAMU 192/serviço de emergência.

06. Em suspeita de celulite não complicada, providenciar avaliação médica em prazo compatível com gravidade.

07. Monitorar resposta ao tratamento prescrito e reavaliar progressão.

08. Documentar sinais, avaliação, decisão e orientação de retorno.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dor desproporcional, progressão rápida, bolhas hemorrágicas, instabilidade: emergência. Na emergência, acionar SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar marcação de progressão e retorno se febre ou piora, sem atrasar atendimento.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

NICE NG141 Cellulitis and erysipelas antimicrobial prescribing; IDSA SSTI 2014 | Conferir aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.